

7 MAYIS 2026

Yaşlılarda Kırılğanlık

Birinci Basamakta Erken Tespit ve Müdahale

Dr. Sadık Barış Adıgüzel

Aile Hekimliği

Kırılğanlık Nedir?

✗ Sadece Yaşlılık Değildir

Biyolojik yaş kronolojik yaştan bağımsızdır. Kırılğanlık, yaşlanmanın veya "çok hastalığı olmanın" (komorbidite) kaçınılmaz bir sonu değildir.



Rezerv Kaybıdır

Stresörlere (enfeksiyon, düşme, cerrahi) karşı homeostatik rezervin ve iyileşme kapasitesinin tükenmesi sendromudur.



Komorbidite vs Kırılğanlık: Kalp yetmezliğinizin olması komorbiditedir. Ancak o kalp yetmezliği hastasının hafif bir idrar yolu enfeksiyonunda deliryuma girip yatağa bağımlı hale gelmesi **Kırılğanlıktır**.

Neden Kırılğanlık?



Paradigma Değişimi: Kırılğanlık yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonu değildir. Erken evrede (pre-frail) **tamamen geri çevrilebilir!**

Ref: Xue QL. The Frailty Syndrome (2011) / Garfinkel D. Deprescribing in Frail Older Adults (2015)

Buzdağının Altı: Inflammaging



Kas-Beyin Aksı: Düşük kas gücü (kavrama), kognitif yıkımın en güçlü öngördürücüsüdür.

Poliklinikte 1 Dakikalık Tarama: FRAIL

65 yaş üstü her hastaya yılda bir kez sorulmalı.

0 = Sağlıklı | 1-2 = Pre-frail (Geri çevrilebilir) | 3-5 = Kırılgan (Yönetim Gerekir)



Yorgunluk (Fatigue): Yaşlanmanın doğal bir sonucu değil, **kırılganlığın ilk ve en sık görülen** çekirdek semptomudur. Depresyon veya "yaşlılık" ile karıştırılmamalıdır.

Ref: Morley JE et al. FRAIL scale (2012) / UpToDate: Approach to the adult patient with fatigue

Hızlı klinik karar vermek için yargıya dayalı görsel ölçek.

Puanlama: Bağımsızlık düzeyi ve Günlük Yaşam Aktivitelerine (GYA) göre yapılır.

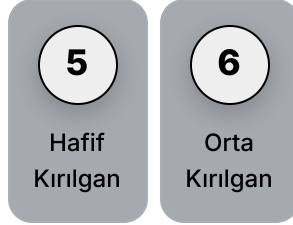
1-4: Bağımsız

Günlük işlerini (GYA) yardımsız yapar.



5-6: Kısmi Bağımlı

Alışveriş, banyo vb. işlerde destek gerekir.



7-9: Tam Bağımlı

Kişisel bakımda bağımlı veya terminal.



Klinik İpucu: CFS 5-6 düzeyindeki hastalar, IADL (alışveriş, para yönetimi) desteğine ihtiyaç duymaya başlayan, birinci basamakta düşme riski en yüksek gruptur.

Ne Ekleyelim? Egzersiz & Protein

En Güçlü İlaç: Egzersiz

Kırılğanlığı önlemede ve tersine çevirmede kanıt düzeyi en yüksek müdahale.

- Haftada 2-3 gün **direnç egzersizi** (kas kütlesi için)
- Haftada 2 gün **denge/Tai-Chi** (düşmeyi önlemek için)
- Aerobik yürüyüşler

Temel Reçete: Protein

Yaşlılarda anabolik direnci kırmak için porsiyon başı doz önemlidir.

- **Hedef:** 1.2 - 1.5 g/kg/gün protein
- Kritik Eşik: Her ana öğünde **~30 gram protein**
- İleri evrede/sarkopenide: D vitamini ve ek takviyeler.

Ref: ICFSR 2024 International Clinical Practice Guidelines for Frailty

Ne Çıkaralım? Deprescribing

Polifarmasi, kırılğanlığın hem **nedeni** hem de **sonucudur**.

- Uygunsuz ilaçların kesilmesi, hayat kalitesini artırır ve düşmeleri azaltır.
- **Sıkı Kontrol Riski:** Kırılğanlarda SKB'yi <130 mmHg'ye zorlamak veya sıkı HbA1c kontrolü mortaliteyi artırabilir.
- **Terminal Evre:** Beklenen ömrü <12 ay olanlarda statinlerin kesilmesi yaşam kalitesini artırır.



Böbreklere Dikkat: Yaşlılarda serum kreatinin *normal olsa bile* GFR düşük olabilir. Dozlar her zaman kreatinin klerensine göre ayarlanmalıdır.

İlk Gözden Geçirilecekler:

Benzodiazepinler / Sedatifler

Düşme, Deliryum

Antikolinerjikler

Kognitif Yıkım

PPI (Uzun Süreli)

B12 ve Mg Eksikliği

SSRI / Tiyazid Diüretikler

Hiponatremi

Ref: STOPP/START criteria / UpToDate: Deprescribing

Gizli Tehlike: Reçete Şelalesi

"Her yeni semptom, aksi ispatlanana kadar bir ilacın yan etkisidir."



Asetilkolinesteraz İnhibitörü → İnkontinans → Antikolinerjik döngüsü de demans hastalarında sık görülen tehlikeli bir şelaledir.

Ref: UpToDate: Drug prescribing for older adults (Prescribing Cascades)

Ufukta Ne Var? Biyobelirteçler

Gelecekte yaşlılık, kronolojik değil **biyolojik yaş** üzerinden takip edilecek.



GDF-15

Mitokondriyal stres belirteci. Kanda yükselmesi kas yıkımının (sarkopeni) erken habercisidir.



Epigenetik Saatler

DNA metilasyonuna bakarak hücrenin gerçek yaşlanma hızını (örneğin DunedinPACE) ölçen sistemler.



Sistemik İmmün İndeksi (SII)

Basit hemogramdan ($\text{Trombosit} \times \text{Nötrofil} / \text{Lenfosit}$) hesaplanan, inflamasyon ve kırılganlık öngörücüsü.

Ref: Belsky DW (2022) DunedinPACE / Patel MS (2023) GDF-15 in Frailty

? Sınır Çizgisi: Sürpriz Soru

*"Bu hastanın önümüzdeki **12 ay** içinde hayatını kaybetmesi beni **şaşırtır mı?**"*

EVET, Şaşırtır

Kırılganlığı tersine çevirmeye odaklan.
Egzersiz, beslenme, tedavi optimizasyonu.

HAYIR, Şaşırtmaz

Beklenen yaşam süresi kısıtlı.
Palyatif Bakım planlamasını başlat.



Geçiş Noktası: Kırılganlığın terminal evresi (CFS 8-9), Nadire Hoca'nın bahsedeceği Palyatif Bakım yaklaşımlarının devreye girdiği yerdir.

Ref: Gold Standards Framework (GSF) Proactive Identification Guidance

Aile Hekimi Cep Algoritması



Bilimsel Kaynaklar

- UpToDate: *Frailty*
- UpToDate: *Deprescribing in older adults*
- UpToDate: *Drug prescribing for older adults*
- UpToDate: *Approach to the adult patient with fatigue*
- ICFSR 2024 International Clinical Practice Guidelines for Identification and Management of Frailty.
- Xue QL. *The Frailty Syndrome: Definition and Natural History*. Clinics in Geriatric Medicine (2011).
- Rockwood K. *A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people (CFS)*. CMAJ (2005).
- O'Mahony D. *STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people*. Age and Ageing.
- Garfinkel D. *Deprescribing in Frail Older Adults* (2015).

Teşekkürler

Sorularınız?



Dr. Sadık Barış Adıgüzel

Aile Hekimliği · 7 Mayıs 2026